

Obok cierpienia *nie zamiast*

Posttraumatyczny wzrost (ang. posttraumatic growth) jest możliwością, nie wymogiem. Występuje obok cierpienia, nie zastępuje go. To nie „jasna strona” traumy.

CZAS: 10 min refleksji + długoterminowa obserwacja **REALIZACJA:** Faza 3 — nigdy w ostrej fazie

ŹRÓDŁO: Tedeschi & Calhoun (1996, 2004, *posttraumatic growth* i PTGI); Shakespeare-Finch & Lurie-Beck (2014, metaanaliza); Joseph & Linley (2005, *organismic valuing theory*); Jayawickreme & Blackie (2014, krytyka)

JAK UŻYWAĆ

W sekcji 01 — **pięć domen wzrostu** Tedeschiego & Calhouna: relacje, nowe możliwości, siła osobista, docenianie życia, zmiana duchowa lub egzystencjalna. W sekcji 02 — **kluczowe zastrzeżenia**: PTG *nie* oznacza, że trauma była „dobra”; *nie* jest celem terapii; *nie narzucaj*. Sekcja 03 — **twoja obserwacja** (jeśli i tylko jeśli zaczynasz dostrzegać zmiany). Sekcja 04 — sygnały *toxic positivity*.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Posttraumatyczny wzrost (Post-Traumatic Growth, PTG; Tedeschi & Calhoun, 1996, 2004): pozytywne zmiany psychologiczne *doświadczane w wyniku zmagania* z wysoce trudnymi okolicznościami życiowymi. **Pięć domen**: (1) *relacje z innymi* — głębsze, bardziej empatyczne; (2) *nowe możliwości* — nowe ścieżki życiowe, zainteresowania; (3) *siła osobista* — „skoro to przeżyłem, przeżyję wszystko”; (4) *docenianie życia* — przewartościowanie priorytetów; (5) *zmiana duchowa lub egzystencjalna* — poszukiwanie sensu. Tedeschi & Calhoun (2004): PTG występuje u **30-70% osób po traumie**. **Kluczowe zastrzeżenia**: PTG *nie* oznacza, że trauma była „dobra” lub „potrzebna”. PTG występuje *obok* cierpienia, *nie zamiast* („i cierpię, i rosnę” — dialektyka). PTG *nie* jest celem terapii — jest *możliwym* efektem ubocznym zmagania. **Nie narzucaj** PTG pacjentowi — „*pomyśl, czego się nauczyłeś*” w ostrej fazie = *inwalidacja*. Shakespeare-Finch & Lurie-Beck (2014, metaanaliza): PTG koreluje z *niższym* dystresem długoterminowo, ale *wyższym* krótkoterminowo — wzrost wymaga *zmagania*, nie unikania. Joseph & Linley (2005, *organismic valuing theory*): wzrost wynika z naturalnej tendencji organizmu do integracji doświadczeń. Jayawickreme & Blackie (2014, krytyka): czy PTG to rzeczywista zmiana, czy *narracyjna iluzja*? Empiryczna trafność jest dyskutowana. **Klinicznie**: terapeuta entuzjastyczny używa PTG jako *nakazu*: „*znajdź coś dobrego w tym, że to się stało*”, „*trauma cię uczyniła silniejszą*”. Klientka czuje się zmuszona do pozytywnej narracji, gdy nadal cierpi. To *toxic positivity* — wzmacnia wstyd i izolację, podważa walidację. Skuteczne podejście: PTG jako *obserwacja*, nie zadanie. Terapeuta *nie* inicjuje rozmowy o wzroście — czeka, aż klient sam zauważy zmiany. Walidacja cierpienia najpierw: „*to było okropne i nie chciałabym, żebyś to przeżyła*”. Potem (czasem po latach): „*zauważyłam, że ostatnio mówisz o nowych przyjaciółach...*”. Niewymuszone. Dla 30-70% to się dzieje. Dla pozostałych 30-70% — nie, i to też jest w porządku.

01 Pięć domen postraumatycznego wzrostu (Tedeschi & Calhoun)

1 · RELACJE Z INNYMI

Głębsze, bardziej empatyczne. „*Lepiej rozumiem, co czują inni cierpiący. Wybieram mniej, ale głębsze relacje.*”

2 · NOWE MOŻLIWOŚCI

Nowe ścieżki życiowe. „*Po terapii zacząłem inny kierunek studiów / wybrałam zawód pomocowy / odkryłam pasję, której bym nie odkryła.*”

3 · SIŁA OSOBISTA

„Skoro to przeżyłem, przeżyję wszystko.” Większe zaufanie do siebie. *Nie* jako „*twarda skóra*”, ale jako wiedza, że można się złamać i wrócić.

4 · DOCENIANIE ŻYCIA

Przewartościowanie priorytetów. „*Rzeczy, które wcześniej były ważne, już nie są. Cieszę się rzeczami, których wcześniej nie zauważałam.*”

5 · ZMIANA DUCHOWA / EGZYSTENCJALNA

Poszukiwanie sensu. Religijna, duchowa, filozoficzna — różnie dla różnych osób. „*Zacząłem inaczej myśleć o tym, po co tu jestem*”. Nie wymóg — dla niektórych ważne, dla innych nie.

02 ? Kluczowe zastrzeżenia — czym PTG *nie* jest

PTG *nie* oznacza, że trauma była „dobra” lub „potrzebna”. Trauma nadal była zła. PTG to twoja praca i twoje zmaganie, *nie* dar od krzywdziciela.

PTG występuje *obok* cierpienia, *nie zamiast*. „*I cierpię, i rosnę*” — dialektyka. Nie musisz wybierać między tymi doświadczeniami.

PTG *nie* jest celem terapii. Jest możliwym efektem ubocznym zmagania. Cel terapii: redukcja cierpienia, integracja, jakość życia. Wzrost — jeśli przyjdzie, przyjdzie.

PTG *nie* jest dla każdego. Tedeschi & Calhoun (2004): 30–70% przeżywających doświadcza PTG. Dla pozostałych 30–70% — nie. To też jest w porządku. Nie ma „właściwego” sposobu na przeżycie traumy.

03 ✎ Moja obserwacja (jeśli zaczynam dostrzegać zmiany)

Nie zmuszaj się do pozytywnej narracji. Wypełnij *tylko*, jeśli zauważasz coś spontanicznie.

CO SIĘ ZMieniŁO W MOICH RELACJACH

— np. głębsze rozmowy, mniej powierzchowności, większa empatia; lub nadal się *nie* zmieniło — i to jest w porządku

CO DocENIAM DZIŚ, CZEGO NIE DocENIAŁEM/-AM WcZĘŚNIEJ

— konkretne rzeczy, sytuacje, ludzie; krótkie obserwacje, bez pretensji do filozofii

CO POTRAFIĘ DZIŚ, CZEGO NIE POTRAFIŁEM/-AM ROK TEMU

— umiejętności regulacji, asertywność, samowalidacja; dowody, że pracujesz nad sobą

CO NADAL BOLI — I MA PRAWO BOLEĆ

— wzrost *nie* znosi cierpienia; równolegle ważne jest oddanie cierpieniu jego miejsca

Klucz: postraumatyczny wzrost jest *obserwacją*, nie *zadaniem*. Najszkodliwsze użycie PTG to *toxic positivity*: „znajdź coś dobrego w tym, że to się stało”, „trauma cię uczyniła silniejszą”, „wszystko dzieje się dla powodu”. Te zdania *inwalidują* cierpienie, wzmacniają wstyd („powinna być wdzięczna, a jestem rozbita”), nakładają obowiązek pozytywnej narracji. Skuteczne podejście: *walidacja pierwsza, wzrost drugi (jeśli w ogóle)*. Klinicysta *nie* pyta „czego się nauczyłeś?” w ostrej fazie. Czekaj, aż klient sam zauważy zmiany — czasem po latach. Wtedy obserwacja jest *autentyczna*, nie wymuszona. Joseph & Linley (2005): wzrost wynika z naturalnej tendencji organizmu do integracji — *nie* trzeba go „pracować”. Wystarczy stworzyć warunki: bezpieczeństwo, walidacja, czas, wsparcie. Reszta dzieje się sama, lub się *nie* dzieje — obie sytuacje są w porządku.

△ Jeśli ktoś bliski lub klinicysta naciska cię w stronę pozytywnej narracji, gdy nadal cierpisz — to *nie* twoja wina, że „nie potrafisz znaleźć dobra”. To *toxic positivity* z ich strony. Masz prawo powiedzieć: „jeszcze cierpię, jeszcze nie widzę wzrostu, i to jest w porządku”. Wzrost *nie* jest dowodem dobrego radzenia sobie. Walidacja cierpienia jest.